Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Garibaldi

Rua Francisco Menegheti, 130 - Bairro: Centro - CEP: 95720000 - Fone: (54) 3022-9843 - Balcão virtual 54-99959-4785 - Email: frgaribaldvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001943-17.2021.8.21.0051/RS

AUTOR: VITORIA AGATTI GNATTA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICIPIO DE CORONEL PILAR / RS

SENTENÇA

1.- Relatório [artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil].

VITORIA AGATTI GNATTA ajuizou *ação para fornecimento de medicação* em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR**, partes já qualificadas. Narra ser portadora de ***fibrilação atrial paroxística (CID I48) - hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia***, ao passo que para o seu tratamento, necessita recorrer ao uso do medicamento ***eliquis (apixabana 5mg)***, ministrado na quantidade de 1 comprimido, via oral, de 12/12 horas, conforme faz prova os documentos anexados aos autos. Requer, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento pela parte requerida, ou o valor em dinheiro para sua aquisição. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, pelo tempo necessário para o tratamento. Instruiu com documentos.

Recebida a inicial, concedida a gratuidade judiciária e deferida a medida liminar, evento 3, DESPADEC1.

Citados, os requeridos apresentaram contestação em evento 13, CONT1 e evento 22, CONT1. Discorreram, em suma, acerca da responsabilidade solidária dos entes, assim como sobre a necessária demonstração da incapacidade financeira da parte que postula a concessão do medicamento. Pediram a improcedência da ação.

Houve réplica às contestações, evento 14, RÉPLICA1 e evento 31, OUT1.

Intimado, o Ministério Público declinou de intervir, evento 62, PROMOÇÃO1.

Realizada perícia na área de cardiologia, sobreveio o laudo médico no evento 89, PERÍCIA1, do qual foi dado vista às partes.

Ante o descumprimento da liminar deferida, foram efetivados diversos bloqueios judiciais no feito para aquisição do medicamento e apresentadas as respectivas prestações de contas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

2.- Fundamentos [artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil].

2.1.- Prestação de contas.

De plano, diante da nota fiscal acostada em evento 142, OUT2, estando em conformidade com o valor do fármaco adquirido, **homologo** a apresentação de contas havida.

2.2.- Mérito.

Cuida-se de ação em que a autora postula a condenação dos requeridos ao fornecimento de medicamento para o tratamento da patologia que a acomete.

A matéria discutida nestes autos é pacífica na jurisprudência do TJ/RS e das Cortes Superiores. O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal como sendo acessível a todos e dever do Estado, em todas as esferas de governo, cabendo igualmente à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, a elaboração de políticas públicas voltadas a sua promoção e preservação, no que se inclui a dispensação de fármacos àqueles que não têm condições de adquiri-los com recursos próprios, assim como de atendimento médico, hospitalar e cirúrgico.

A legislação infraconstitucional também é generosa ao garantir a defesa ao direito à saúde (art. 15 do Estatuto do Idoso; art. 2º da Lei 8.808/90; art. 241 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; dentre outros exemplos).

Como decorrência da solidariedade existente entre os entes da Federação, pode a parte autora optar por demandar contra qualquer um deles, em conjunto ou separadamente, em face do que tanto um quanto o outro é legitimado a figurar no polo passivo. Eventual divisão de competências realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde não se sustenta em oposição ao direito fundamental à saúde e, consequentemente, à vida.

Assim, não há dúvidas de que compete aos entes federados, solidariamente, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos visando a assistência à saúde.

É incontroverso o dever do Estado (*lato sensu*) garantir aos cidadãos carentes o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, dentre os quais está incluída a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, de forma gratuita.

Nesse aspecto, a Lei estadual n.º 9.908/1993 regulamenta a disponibilização de fármacos excepcionais (aqueles "*que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente*"; parágrafo único do art. 1º) e dispõe, em seu art. 1º, que "*O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família*".

Destarte, uma vez demonstrada a necessidade de utilização do fármaco e a impossibilidade econômica do postulante arcar com o tratamento por conta própria, bem como existindo elemento de prova de que o medicamento indicado para tratamento da patologia não pode ser substituído por outro – claro que essa situação deve ser suficientemente justificada pelo médico que acompanha o paciente –, configurada está a responsabilidade do Estado (lato sensu) à concessão.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Não há controvérsia sobre o estado de saúde da autora, em razão dos documentos que instruem o feito.

No caso dos autos, o laudo médico demonstra a necessidade da utilização do medicamento postulado, bem como o risco pelo não uso, circunstância que pode levar a requerente a significativa piora do seu estado clínico.

CONCLUSÃO

Baseado na história clínica, exame fisico e laudos médicos acostados ao processo, conclui-se que a periciada é portadora do diagnóstico de fibrilação atrial paroxística (CID 10: I 48).

Com relação ao fármaco pleiteado no processo:

Apixabana:

Anticoagulante oral, da classe dos inibidores diretos do fator Xa. A autor é portadora do diagnóstico de fibrilação atrial, que é uma indicação deste fármaco. Os medicamentos habitualmente empregados no tratamento de anticoagulação crônica são os cumarínicos (como a Varfarina), que são disponibilizados gratuitamente à população, por estarem incluídos na lista dos Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica. No estudo ARISTOTLE houve a randomização de 18.201 pacientes com fibrilação atrial e risco de apresentar eventos tromboembólicos, para fazer a comparação da eficácia da Apixabana versus a Varfarina. Os resultados encontrados evidenciaram que a Apixabana não foi inferior à Varfarina na prevenção de eventos tromboembólicos. Evidenciou inclusive uma redução na taxa de mortalidade e de acidentes vasculares cerebrais, tanto hemorrágicos como isquêmicos. Foi mais segura que a Varfarina, pois apresentou uma taxa de sangramento maior inferior a esta. **Neste sentido, a indicação da Apixabana está correta.**

O requisito atinente à hipossuficiência econômica da autora também restou demonstrado, uma vez que os seus rendimentos como produtora agrícola variam entre R$ 2.400,00 a R$ 3.750,00 mensais, enquanto o medicamento custa, em média, R$ 270,00 por mês.

Destarte, não restam dúvidas de que o medicamento pleiteado é indispensável ao seu tratamento.

É verdade que os recursos dos entes públicos são limitados, há demandas inúmeras, ordem de prioridades, necessidade de regulação de um sistema universal e único, sujeito a controle, que não prescinde da observância de isonomia de atendimento entre cidadãos [alargar direito a um, pode significar sacrifício de uma coletividade], mas a amplitude constitucional e infraconstitucional atribuída ao tema é de garantia do direito social à saúde, o entendimento jurisprudencial é pacífico, daí só resta ao juízo fazer alguma ressalva de entendimento em determinados casos, mantida a declaração do direito por racionalidade judiciária, por visão sistêmica do sistema de Justiça e de garante de direitos.

O fornecimento do medicamento deve observar a denominação comum brasileira.

3.- Dispositivo [artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil].

Isso posto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO **procedente** o pedido para o fim de condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento ***eliquis (apixabana 5mg)*** em favor da autora, de forma contínua e por tempo indeterminado, enquanto perdurar a sua necessidade.

A demandante deverá entregar aos requeridos atestado médico semestral que comprove que a necessidade do medicamento persiste.

Condeno os requeridos ao pagamento da taxa única dos serviços judiciais e honorários advocatícios devidos à procuradora da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa (50% cada), atentando aos parâmetros do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho desempenhado e da natureza da demanda.

Interposta(s) apelação(ões), intime(m)-se o(s) apelado(s) para contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Havendo preliminares nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) apelante(s) para manifestação (prazo 15 dias). Caso interposta apelação adesiva pelo apelado, intime-se o apelante para contrarrazões, querendo (prazo 15 dias).

Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do RS, na forma do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, nada pendente, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA, Juiz de Direito**, em 25/4/2024, às 18:16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10059279368v2** e o código CRC **1bd1adb5**.